

RUBENS CALASANS	
HD:	APNEIA DO SONO
MEDICO:	DR ALBERTO
MEDICAMENTOS:	
IMC	32.19
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	P=8cmH ₂ O
30/11/20	Pct _e relatou que esta bem adaptado.
	Relatou que esta com dificuldade p/ expirar ↑ o APE.
10/12	Liguei e disse que conseguiu dormir melhor.
21/12	Mandei msg, enviei relatório. Fuga de ar importante.
22/12	Pct _e relata que esta retirando CPAP, sabendo.
	Precisa ↑ n.º de horas de uso — Jua
05/01	Pct _e expreico, s/ queixar.
	P=8cmH ₂ O
	IAH=4.9/lr.
	Fuga=16.l/min. — Jua.
20/01	Pct _e ainda c/ dificuldade para colocar o CPAP.
	IAH=4.4. — m. de uso: 4h20' Jua.
03/08	P=8.0
	IAH=3.1
	m. de uso 4:30 Jua
02/09	P=8.0
	IAH=3.8
	m. de uso: 5h20 Jua

05/11

P = 8
IAH = 2.4
m. de uso: 4h12'
ajusto máscara.

fua.

11/02/22

P = 8
IAH = 0.8
m. de uso: 5hs.

Bem adaptado, só não está melhor pois tem dias que não utiliza

fua

20/06/22

P = 80 cmH₂O / IAH = 3.0 / m. de uso: 5h25'

Bem adaptado, porém fua alguns dias e utiliza

fua

22/11/22

P = 8 cmH₂O
IAH = 2.8 e/h
m. de uso: 5h16'
Fuga = 13.8 l/min

Bem adaptado, está utilizando porém deixa alguns dias e uso.

fua.

24/02/2023

P = 8 cmH₂O
IAH = 5.7
média uso = 4h30 min
fuga 14.7

Bem adaptado; melhora mto au qdo. coloca; ↓ P. inicial 4. recompa 10 min
↑ APE 3 na recompa

26/04/23

P = 8 cmH₂O
m. de uso: 5h11
IAH = 3.2
fuga = 20.7

troco o fixador

fua.

11/09/23

P = 8 cmH₂O
IAH = 2.3 e/h
m. de uso: 5h30'

* trocar a máscara na prox. consulta

* troquei o filtro

está deixando de usar alguns dias. - fua

10/01/24

P = 8 cmH₂O
m. de uso: 5h30'
fuga = 22.7

Bem adaptado, porém tem falhas por conta das viagens.

fua.

12/04/24

P = 8 cmH₂O
IAH = 3.3 e/h
m. de uso: 5h27m
deixa de usar alguns dias

Bem adaptado

* troco filtro

Notado

14/08/24 P=8aw H₂O
IAH= ~~600400~~ 3,9 el/h
m de euro: 6h45
fuga P95: 16,2 el/m

Bem adaptado
Quando viaja não
usa.
Natacha

13/11/24 P = 8 cm H₂O
IAH = 3,2 x/h
-fuga = 22 l/min
muro = 6 horas

sugiro boca da máscara → Não quis boca
silva

14/02/25 $P = 8 \text{ au H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,2 \text{ e/h}$
 med. um: 6.25'
 fuga: 17 fl/m

Bem adaptado
Siqueiras

Natasha

13/05/25 $p = 8 \text{ atm}$
 $I_{AH} = 3,6 \text{ e/h}$
 m de uso: 6h29'
 flego: 17,7 l/m

Paciente se sentir
melhor utilizando
o CPAP

Natacha

Nome: RUBENS CALASANS CAMARGO JR

Data de Nascimento: 31-8-1963

IMC: 32,19

Sexo: Masculino

Data do exame: 24-10-2020

Peso: 102 kg

Altura: 1,78 m

Médico: DR. ALBERTO JORGE R. LOPEZ

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 24-10-2020, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 433,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 11,5 e 255,5 minutos. O tempo total de sono foi de 433,0, eficiência de 56,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,1%; estágio N2: 67,6%; estágio N3: 13,6%; sono REM: 15,7%. O índice de despertares foi de 3,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 3,4, sendo elas 8 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 6 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 77%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 72 bpm e NREM de 51 - 71 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco intenso durante o sono.

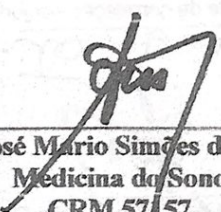
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157